

 Hôpitaux Universitaires Genève Département de gynécologie et d'obstétrique	Type de document : Document départemental Sous type : Fiche d'attitude	Nombre de pages : 1/3
SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE A BAS RISQUE		Portée : Service d'Obstétrique
Rédacteur : Dre G. Martilloti, Dre N. Jastrow Meyer, Dre Isabelle Eperon, Pre B. Martinez de Tejada Modifié le : 30.10.2012, 12.04.2013 5.01.2016 – 14.04.2016	Responsable du document : Pr O. Irion, Pre B. Martinez de Tejada	Approuvé le :24.05.2016 Approuvé par : Pre B. Martinez de Tejada - Prof O Irion

**1^{ère} consultation,
<12^{ème} semaine de
grossesse:**

Anamnèse

Antécédents familiaux (Anamnèse génétique selon population), personnels, gynécologiques, obstétricaux, situation sociale

Médicaments, allergies, tabac, drogues, alcool

DR, cycles, contraception

Status vaccinal (varicelle, rougeole, rubéole, grippe, coqueluche*,...)

Status

Poids, taille, TAH, auscultation cardio-pulmonaire

thyroïde, seins, extrémités, abdomen, Status gynécologique

spéculum et TV

Examens

Pap test si indiqué (cf fiche indications au Pap test)

Hb, Ht, thrombocytes, groupe sanguin, AC irréguliers, Ferritine

Syphilis, HBsAg, VIH. Hep C (patiente à risque). Varicelle (si anamnèse négative). Rougeole et rubéole (en absence de carnet de vaccination ou de sérologie précédente).

Test Chagas (population sud-américaine).

Stick urinaire, culture d'urine.

Glycémie à jeun si : ATCD de diabète gestationnel ou de macrosomie, ATCD familiaux de diabète type 2 (premier degré), âge >35 ans, obésité BMI>30, glycosurie, syndrome des ovaires polykystiques

Test de falciformation pour les patientes d'origine africaine et méditerranéen. Si test de falciformation positif : cf fiche examen hématologique

Dépistage séquentiel de la Trisomie 21 : dosage le jour de la consultation de β hCG et PAPP-A. La grossesse doit être au moins âgée de 9 3/7 SA (CRL au minimum de 25 mm). Le dépistage sera complété par la mesure de la CN lors de l'échographie du premier trimestre.

NB : La TSH ne fait pas partie du bilan de prise en charge de la grossesse

Discussion

Expliquer le dépistage prénatal (DT 1^{er} trimestre) et implications, ainsi que les mesures de prévention du CMV, toxoplasmose et Listeria. Distribuer les feuilles d'information sur le suivi de grossesse, l'alimentation et hygiène de vie. Faire signer le consentement éclairé pour le DT 1^{er} trimestre.

Organiser :

Rdv entre 12 et 14 SA à l'unité d'échographie pour l'échographie de datation et le dépistage de la Trisomie 21 ainsi qu'un rdv à la consultation prénatale entre 15 et 18 SA pour une consultation et dosage de l'alphafoetoprotéine

Si détection de facteurs de risque, orientation vers une consultation spécialisée

**Échographie et
double test
12 et 14 SA**

Unité de médecine
fœtale et
d'échographie

Localisation de la grossesse, nombre de fœtus, vitalité.

Contrôle de l'âge gestationnel (CRL) : le terme est corrigé s'il existe une différence de ≥ 5 jours par rapport à l'âge gestationnel défini par les DR

Clarté nucale, contours fœtaux, utérus, tumeurs

Ponction veineuse

Dosage de β hCG et PAPP-A avec calcul du risque de Trisomie 21 si test séquentiel non réalisé auparavant.
 Complément du dépistage de la T21 par mesure de la CN si test séquentiel réalisé.
Le résultat du dépistage est disponible 3 jours plus tard. La patiente reçoit les résultats par courrier.
En cas risque élevé, une consultation est organisée par l'unité de médecine fœtale : seront abordées les différentes options de prise en charge prénatale (abstention d'investigations supplémentaires ; test invasif par chorio-ou amniocentèse ou test prénatal non invasif –NIPT). Le NIPT est pris en charge par l'assurance de base en cas de risque élevé (>1/1000). Pour les patientes avec assurance complémentaire, le médecin en charge de la patiente est aussi informé.

2^{ème} consultation
15-18 SA
Consultations
prénatales

Anamnèse

Status

Poids, TAH, abdomen, BCF.

Examens

Alphafoetoprotéine, ou double test si pas fait au 1^{er} trim.
 Stick urinaire**

Discuter

Résultats des examens précédents

Préparation à la naissance,
Prendre un rdv pour l'échographie morphologique entre 20-22 SA et une consultation à 24-26 SA

Échographie
morphologique
20 SA

Morphologie, croissance, vitalité fœtale, liquide amniotique, localisation placentaire, mesure longueur col (LC) par voie abdominale. Si LC < 35mm, ad mesure par voie endovaginale***

Unité de médecine
fœtale et
d'échographie
3^{ème} consultation
24-26 SA
Consultations
prénatales

Anamnèse

Mouvements fœtaux, (signes de PE, CU, perte de LA.)

Status

Poids, TAH, fond utérin (FU), œdèmes, BCF

Examens

Hb, Ht, thrombocytes, Stick urinaire**
 Dépistage du diabète gestationnel (24-28 SA) : HGPO avec 75g (donner la feuille de demande d'examen)

4^{ème} consultation
30 -32 SA
Consultations
prénatales

Anamnèse

Mouvements fœtaux, (signes de PE, CU, perte de LA)

Status

Poids, TAH, œdèmes, FU,
 estimation de la présentation et du poids fœtal, BCF

Examens

stick urinaire**
 AC irréguliers si Rh négatif et pas de Rhophylac effectué.
 Si Rh négatif Rhophylac ad 300 μ g
 Refaire HbsAg et VIH chez les patientes à risque.
 Pour les patientes avec ATCD de césarienne avec désir de tentative d'accouchement vaginal et absence de contre-indications, prévoir un RDV entre 36 0/ 7 SA et 38 0/7 SA pour la mesure du segment inférieur et discussion du mode d'accouchement à la consultation AVAC (accouchement vaginal après césarienne)

5^{ème} consultation
36-37 SA
Consultations
prénatales

Anamnèse

Mouvements fœtaux, signes de PE, CU, perte de LA

Status

Poids, TAH, œdèmes, FU, estimation de la présentation et du poids fœtal, BCF
 Si suspicion de macrosomie, cf fiche macrosomie

	Examens Stick urinaire** Culture vagino-rectale : dépistage portage streptocoque du groupe B 35-37 SA (cf fiche Streptocoque B) Discuter Les signes du début du travail, quand venir à la maternité ? Plan de naissance
6^{ème} consultation 39-40 SA <u>Consultations</u>	Anamnèse Mouvements fœtaux, signes de PE, CU, perte de LA Status Poids, TAH, œdèmes, FU, estimation du poids fœtal, BCF, présentation fœtale,
<u>Unité de médecine fœtale et d'échographie</u>	US pour croissance, AFI et Doppler, à partir 40 0/7 SA (au plus tard 40 4/7) Examens Thrombocytes si risque de thrombopenie (prééclampsie, HELLP syndr., Thrombopénie gestationnelle, Syndr hémolytique-urémique, coagulopathie, pathologie connue des plaquettes, maladie autoimmune , etc) stick urinaire** Discuter Les signes du début du travail, quand venir à la maternité ? (cf. document)
Entre 41 0/7 SA et 41 3/7	Déclenchement de l'accouchement
<u>Unité de médecine fœtale et d'échographie</u>	Répéter l'US si il a été effectué à plus de 7 jours d'intervalle entre la dernière consultation et le jour prévu de la provocation

- * Proposer la vaccination contre la grippe durant la grossesse ou dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement durant la période de grippe. Proposer le vaccin contre la coqueluche dès 14 semaines, soit au plus tard au post-partum à toutes les femmes avec un dernier rappel coqueluche datant de plus de 5ans
- ** Si leucocytes $\geq +$, toilette à la Chlorhexidine aqueuse des organes génitaux externes. Refaire stick sur urines mi-jet. Si leucocytes persistent ou présence de symptômes d'infection urinaire, ad culture d'urine.
- *** Si LC endovaginale <25mm, ad utrogestan® 200 mg 1x/j par voie vaginale jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée et prévoir RDV à la consultation prévention de la prématurité

- Conseils Toxo/Listeria :**
Laver fruits/légumes
Pas d'œuf cru
Pas viande crue, charcut
Pas de sushi
Pas de from. lait cru
Limiter caféine
Pas faire le jardin
Pas caisse du chat

Mère

Suivi grossesse

Enfant

